رقم السياسة	SH.EQR.39.QPI.11		
عنوان السياسة	إدارة وتحليل الأحداث الجسيمة		
تاريخ إعداد	2026/03/01	رقم الإصدار	1
تاريخ تفعيل	2026/04/01	تاريخ اعتماد	2026/04/01
تاريخ المراجعة	2029/04/01	عدد الصفحات	6
نطاق التفعيل	جميع الإدارات بالمستشفى		

إعداد	مراجعة	اعتماد
فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد	لجنة الجودة د/ ايمان سامي	مدير المستشفى د/ وسام وهيبه

د/ إيمان سامى السيد
مديرة الجودة
مستشفى صيدناوى

السياسة

- توفر المستشفى قائمة للأحداث الجسيمة
- يجب الإبلاغ الفوري (خلال 24 ساعة كحد أقصى) عن أي حدث جسيم للإدارة العليا وقسم الجودة.
- تلتزم إدارة المستشفى بتشكيل فريق متعدد التخصصات لإجراء "تحليل الأسباب الجذرية (RCA) "لأي حدث جسيم يقع.
- يجب الانتهاء من تقرير الـ RCA واعتماد "خطة العمل التصحيحية "و تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز **45 يوماً** من تاريخ وقوع الحدث.
- الغرض
- ضمان الاستجابة السريعة، الفعالة، والشفافة لأي حدث جسيم (Sentinel Event) يقع في المستشفى، وتوفير الدعم للمرضى المتضررين والطواقم الطبية، وإجراء تحليل عميق لـ "الأسباب الجذرية" (RCA) بهدف إصلاح الأنظمة ومنع تكرار الحدث، مع ترسيخ "ثقافة عدم اللوم"

التعريفات

- **نموذج الإبلاغ عن الحوادث (OVR - Occurrence Variance Report):** النموذج المستخدم لتوثيق أي حدث غير متوقع يقع داخل المنشأة.
- **الحدث الوشيك (Near Miss):** خطأ كاد أن يسبب ضرراً ولكن تم اكتشافه وتداركه قبل أن يصل للمريض.
- **الحدث الضار (Adverse Event):** أذى لحق بالمريض نتيجة للرعاية الصحية وليس بسبب حالة المريض الأساسية.

- **الحدث الجسيم (Sentinel Event):** حدث غير متوقع يتعلق بالرعاية الصحية يؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بضرر جسدي أو نفسي بالغ ودائم، ولا يتعلق بالمسار الطبيعي لمرضه.

- **تحليل الأسباب الجذرية (RCA):** عملية منهجية استرجاعية تركز على مراجعة الأنظمة والعمليات (وليس الأفراد) لمعرفة "لماذا" و "كيف" وقع الحدث.
- **الثقافة العادلة (Just Culture):** بيئة تشجع على الإبلاغ وتدرك أن الأخطاء البشرية واردة، وتركز على إصلاح عيوب النظام بدلاً من معاقبة الأفراد (إلا في حالات الإهمال المتعمد أو السلوك الإجرامي).

إجراءات

1. يتم توزيع قائمة ب امثلة الاحداث الغير متوقعة التي يجب الإبلاغ عنها في كل قسم , مع شرح بنود القائمة و الاستفاضة ب امثلة أخرى مشابهة و غير مشابهة للموجود بالقائمة
2. يتم تدريب الموظفين ب أنواع الاحداث الغير متوقعة (وشيك، سلبي , جسيم)
3. تضمن الأحداث الجسيمة (Sentinel Events)، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

1. الوفاة غير المتوقعة أو الفقدان الدائم والكبير للوظائف الحيوية، والذي لا يرتبط بالمسار الطبيعي لمرض المريض أو حالته الصحية الأساسية.
2. الحوادث المتعلقة بـ مريض خطأ، أو موضع جراحة خطأ، أو إجراء طبي خطأ.
3. انتحار المريض، أو محاولة الانتحار، أو التعرض لعنف يؤدي إلى الوفاة أو فقدان دائم للوظائف.
4. حالات النسيان غير المقصود لجسم غريب داخل جسم المريض بعد الجراحة أو الإجراءات الطبية التداخلية.
5. الخطأ في تقديم العلاج الإشعاعي.
6. أي حالة وفاة للأم مرتبطة بفترة الولادة وما حولها.
7. أي حالة وفاة لحديثي الولادة لا تتعلق بحالة خلقية، لطفل يزن عند الولادة أكثر من 2,500 جرام.
8. تفاعلات نقل الدم الانحلالية الكبرى.
9. حالات الاغتصاب.
10. نشوب حريق.
11. اختطاف الرضع.

الاستجابة الفورية

- عند وقوع حدث جسيم، الأولوية القصوى هي استقرار حالة المريض وتقديم الرعاية الفورية له.
- يقوم مكتشف الحدث بإبلاغ رئيس القسم ومدير الشؤون العلاجية ومدير المستشفى ومدير الجودة فوراً.

الإبلاغ الداخلي

يجب على أي موظف يكتشف وقوع حدث جسيم الإبلاغ عنه "فوراً" باستخدام نموذج الإبلاغ المعتمد (OVR)، وبالتوازي يتم التواصل مباشرة مع الإدارة لتسريع الاستجابة

- **التسلسل الوظيفي:** يتم تصعيد البلاغ داخلياً في نفس اللحظة إلى: (رئيس القسم المعني ← المدير الشؤون العلاجية ← مدير إدارة الجودة ← مدير عام المستشفى).
- **الإطار الزمني:** الإبلاغ الداخلي يجب أن يتم **فوراً**، وابلاغ إدارة الجودة بحد أقصى خلال 24 ساعة من لحظة الاكتشاف
- **الهدف:** تأمين المريض، والبدء الفوري في تشكيل فريق تحليل الأسباب الجذرية (RCA).

الإبلاغ الخارجي

- الإبلاغ الخارجي هو مسؤولية وحق حصري لـ **(مدير عام المستشفى أو من يفوضه رسمياً)**
- **الجهات المعنية:** يتم رفع تقرير رسمي بالحدث الجسيم إلى:
  - هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).
  - وزارة الصحة والسكان
  - الهيئة العامة للتامين الصحي (فرع القاهرة)
  - الجهات الأمنية/الشرطية (فقط في حال وجود اشتباه جنائي كحالات الانتحار، أو الاعتداء المتعمد، أو اختطاف الأطفال).

المحتوى :يتضمن الإبلاغ الخارجي الأولي وصفاً موجزاً للحدث وما تم اتخاذه من إجراءات تأمينية فورية في خلال 48 ساعة، على أن يُتبع لاحقاً بتقرير تحليل الأسباب الجذرية (RCA) المكتمل وخطة العمل منفذة خلال المدة المقررة (45 يوماً)

تحليل الأسباب الجذرية (RCA Process):

1. يشكل مدير المستشفى فريق الـ RCA برئاسة مدير الجودة وعضوية أفراد من الأقسام ذات الصلة (يُفضل ألا يكونوا ممن شاركوا في الحدث مباشرة لضمان الحيادية).

2. يشارك أعضاء الفريق من مختلف الجهات في التقرير المخصص كل فرد حسب التخصص الخاص به(تقرير من الطبيب المعالج ب الملاحظات الإكلينيكية للحالة و الاحداث التي أدت للحدث, تقرير من عضو فريق مكافحة العدوى ب مدى الالتزام ب الإجراءات حينها, الخ...)
3. يقوم الفريق بجمع البيانات، مقابلة الشهود، ومراجعة الملفات بمنهجية "التركيز على النظام وليس الفرد".
4. يستخدم الفريق أدوات تحليل الجودة (مثل مخطط عظمة السمكة Fishbone، وأداة Whys-5) للوصول للسبب الجذري.

5. التحليل يحدد التغييرات التي يمكن إدخالها في النظم والعمليات(إما من خلال إعادة تصميم أو تطوير نظم جديدة أو عمليات جديدة)التي من شأنها أن تقلل من مخاطر مثل هذه الأحداث في المستقبل

6. إذا وجد تحليل السبب الجذري إن الحادث الجسيم كان نتيجة لأداء احد أعضاء الفريق الطبي وله امتيازات إكلينيكية فيتم إدارة الإجراء التصحيحي من خلال لجنة الهيئة الطبية.
7. إذا وجد تحليل السبب الجذريان الحادث الجسيم كان نتيجة لأداء احد أعضاء الفريق الطبي ليس له امتيازات إكلينيكية او احد العاملين بالمستشفى من خارج الفريق الطبي فيتم ادارة الإجراء التصحيحي من خلال رئيس القسم المعنى.
8. اذا وجد تحليل السبب الجذري ان الحادث الجسيم كان نتيجة لخلل بالنظام او عملية معينة بالمستشفى فيتم ادارة الاجراء التصحيحي من خلال عمل مشروع تحسين لوضع خطة تصحيحية وتنفيذها في خلال اطار زمنى لا يتعدى 45 يوم
9. يراعى أثناء وضع الخطة ان يتم تحديد المسئول عن التنفيذ والمراقبة والاختبار التجريبي، ويكون لها إطار زمني محدد.
10. يجب مشاركة إدارة المستشفى والأفراد الأكثر مشاركة في العمليات والنظم المتعلقة بالحدث في تطبيق الخطة التصحيحية

خطة العمل والمتابعة

1. يتم تعيين فريق لل RCA بموافقة مدير عام المستشفى، بمهام موضحة وفترة محددة لرفع تقارير لمدير المستشفى
2. يضع فريق الـ RCA خطة عمل واضحة (تحديد مسؤوليات، إطار زمني، وموارد مطلوبة) لإصلاح الخلل في النظام.
3. يعتمد مدير المستشفى الخطة
4. تتابع إدارة الجودة تنفيذ الخطة وتقيس مدى فعاليتها (Effectiveness Check) بعد فترة للتأكد من عدم تكرار الحدث.
5. يتم رفع تقرير نهائي بما تم انجهازه من الخطة في المدة المقررة: 45 يوم

إجراءات التعامل مع "الضحية الأولى" (المريض وأسرته):

الضحية الأولى هو المريض الذي وقع عليه الضرر المباشر، بالإضافة إلى أفراد أسرته الذين يتأثرون نفسياً واجتماعياً بالحدث.

- **التدخل السريري الفوري:** الأولوية المطلقة هي تقديم الرعاية الطبية الفورية والمجانية للمريض لتلافي أو تقليل حجم الضرر الناتج عن الحدث واستقرار حالته.
- **الإفصاح والشفافية (Open Disclosure):**
  - يتم عقد اجتماع عاجل مع المريض أو أسرته بواسطة فريق طبي مدرب (يضم مدير الشؤون العلاجية والطبيب المعالج).
  - يتم إخبار المريض بصدق وشفافية عما حدث، وكيف حدث (بناءً على الحقائق المتاحة وقتها دون إلقاء لوم على أفراد).
  - تقديم اعتذار صريح ومؤسسي (الاعتذار عن الحدث لا يعني بالضرورة الاعتراف بالمسؤولية القانونية، بل هو تعبير عن التعاطف والالتزام بالرعاية).
- **الدعم النفسي والاجتماعي:** توفير أخصائي نفسي أو اجتماعي لمرافقة المريض وأسرته ومساعدتهم على تجاوز الصدمة، مع إبقائهم على اطلاع مستمر بخطوات التحقيق وما يتم اتخاذه لمنع تكرار الحدث.

إجراءات التعامل مع "الضحية الثانية" (الطاقم الطبي/مقدم الرعاية):

الضحية الثانية هو مقدم الرعاية الصحية الذي شارك (بشكل مباشر أو غير مباشر) في الحدث غير المتوقع، والذي غالباً ما يعاني من صدمة نفسية، شعور بالذنب، قلق، وفقدان الثقة في قدراته.

- **الحماية والإعفاء المؤقت**
  - حماية المقدم للرعاية من اي عواقب واعطاءه وقتا للسماح له بالتعافي من الصدمة، ويمكن تخفيف اعماله او تغيير مكانه مؤقتا مع التوضيح التام له بأن هذا الإجراء **"ليس عقابياً"** بل هو لحمايته وحماية المرضى الآخرين لحين استقرار حالته النفسية.
  - **دعم الأقران** تعيين زميل موثوق أو رئيس القسم للاستماع للموظف ودعمه مهنياً دون إطلاق أحكام.
- **دعم الثقافة العادلة**
  - طمأنة الموظف بأن التحقيق (RCA) يهدف إلى تقييم "النظام" وليس "الفرد".
  - توفير المشورة القانونية والإدارية للموظف لضمان شعوره بالأمان المؤسسي أثناء سير التحقيقات.

- **إعادة الدمج:** وضع خطة تدريجية لعودة الموظف لممارسة مهامه السريرية بشكل كامل، او تغيير مهامه إذا تحتم الامر، بعد التأكد من تعافيه وجاهزيته الفنية والنفسية.

المسؤول عن التنفيذ

- **جميع العاملين:** الإبلاغ الفوري والشفاف عن أي حدث جسيم.
- **إدارة الجودة:** قيادة وتيسير اجتماعات الـ RCA، تدريب الفرق على أدوات التحليل، ومتابعة تنفيذ خطط العمل.
- الأشخاص المنوطة بتنفيذ الخطة التصحيحية
- **الإدارة العليا :**دعم "ثقافة عدم اللوم"، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ التوصيات وتصحيح الأنظمة.

المراقبة والتقييم

- نسبة الأحداث الجسيمة التي تم الانتهاء من إجراء RCA ووضع Action Plan لها و تنفيذها و رفع تقرير بالنتيجة خلال 45 يوماً (الهدف: 100%)

معايير ذات صلة

OGM.01 Governing body Structure and responsibilities, OGM.04 Hospital Director,OGM.08 Hospital leaders, QPI.09 Risk Management Program, QPI.04 Incident Reporting System, APC.01 Accurate and complete information.

المراجع

- دليل معايير اعتماد المستشفيات -الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، إصدار 2025. (معيار QPI.11).